

Trzy warianty *trzy ścieżki kliniczne*

AN ma trzy postacie kliniczne: restrykcyjny, „binge-purge” oraz atypowy. Każdy ma inną dynamikę, inne ryzyka, inne wymagania terapeutyczne.

CZAS: 10–15 min psychoedukacji **REALIZACJA:** po wstępnej diagnozie

ŹRÓDŁO: APA (2013, DSM-5; 2022, DSM-5-TR); Eddy i in. (2008, prospektywne badanie migracji podtypów, 50% AN-R → AN-BP w 5 lat); Sawyer i in. (2016, atypowa AN); WHO (2022, ICD-11)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **trzy podtypy**: restrykcyjny (AN-R), „binge-purge” (AN-BP), atypowy. W sekcji 02 — **migracje podtypów** w czasie i implikacje kliniczne. Sekcja 03 — **specyficzne ryzyka** dla każdego podtypu. Sekcja 04 — pytania diagnostyczne i obserwacja przebiegu.

DLACZEGO TO DZIAŁA

DSM-5-TR (APA, 2022) wyróżnia dwa podtypy AN: **restrykcyjny** (AN-R) — utrata masy przez restrykcję i ćwiczenia, oraz z **napadami/przeczyszczeniem** (AN-BP) — naprzemienne restrykcje i epizody objadania z kompensacją. Podtyp nie jest stały — w ciągu choroby 50–60% pacjentów przechodzi z AN-R do AN-BP (Eddy i in., 2008, *Am J Psychiatry*). Atypowa AN (w kategorii OSFED) — wszystkie kryteria poza niską masą, równie groźna medycznie. Podtyp ma znaczenie dla planu leczenia, ale *nie* dla powagi rokowania.

01 Trzy warianty kliniczne

AN-R · RESTRYKCYJNY

Tylko restrykcja w ostatnich 3 mies. Brak epizodów objadania, brak prowokowanych wymiotów. Niska masa przez post, ścisłą dietę, intensywny ruch. Większa sztywność poznawcza, lęk uogólniony, perfekcjonizm.

AN-BP · „BINGE-PURGE”

Restrykcja + epizody objadania lub kompensacje (prowokowane wymioty, przeczyszczenie, moczopędne) w ostatnich 3 mies. BMI nadal niskie (różnicowanie z BN). Wyższa impulsywność, wyższe ryzyko medyczne — zaburzenia elektrolitowe, arytmie.

ATYPOWA AN

Wszystkie kryteria AN poza niską masą (OSFED w DSM-5; 6B80.Y w ICD-11). Znacząca utrata wagi, te same objawy psychiczne i medyczne, ale BMI w normie. *Najmniej* rozpoznawana — często bez leczenia miesiącami.

02 ? Migracje podtypów + ryzyka specyficzne

Eddy i in. (2008), prospektywne badanie 5-letnie: około 50% pacjentów z AN-R przechodzi w AN-BP w ciągu 5 lat. Mechanizm: długotrwała restrykcja prowadzi do utraty kontroli nad jedzeniem, epizodów objadania, kompensacji. *Nie* traktuj podtypu jako stałej cechy — monitoruj zmiany w czasie.

Ryzyka medyczne specyficzne: AN-BP ma wyższą śmiertelność medyczną — zaburzenia elektrolitowe (hipokaliemia, hiponatremia) z prowokowanych wymiotów prowadzą do arytmii serca; erozja szkliwa, perforacje przełyku. AN-R ma *niższą* impulsywność, ale często cięższe niedożywienie, wyższą sztywność poznawczą.

03 ✎ Pytania diagnostyczne + obserwacja przebiegu

PYTANIE 1 — OBJADANIE

„W ostatnich 3 miesiącach — czy zdarzały Ci się napady jedzenia (zjedzenie dużej ilości jedzenia w krótkim czasie z utratą kontroli)?”

PYTANIE 2 — KOMPENSACJE

„Czy używałeś/-aś prowokowanych wymiotów, środków przeczyszczających, moczopędnych, intensywnego ruchu, by zrekompensować jedzenie?”

MÓJ WSTĘPNY PODTYP

— AN-R / AN-BP / atypowa; data oceny; uwagi (np. niedawna zmiana z R na BP)

PLAN MONITOROWANIA ZMIAN

— co 3 mies. ponowna ocena; znaki ostrzegawcze migracji R → BP (utrata kontroli, epizody)

Klucz: podtyp AN *nie* jest stałą cechą — zmienia się w czasie. Eddy i in. (2008): około połowa pacjentów z AN-R przechodzi w AN-BP w ciągu 5 lat. Mechanizm jest *biologiczny*: długotrwała restrykcja prowadzi do utraty kontroli nad jedzeniem — to *nie* jest „brak silnej woli”, to predyktywna konsekwencja głodzenia (Minnesota Starvation Study — osobny handout). Klinicznie: *monitoruj zmiany* co 3 miesiące, edukuj pacjenta i rodzinę o ryzyku migracji. AN-BP wymaga dodatkowej pracy z cyklem objadanie-kompensacja oraz monitorowania elektrolitowego (potas, sód, fosforany) z powodu wyższego ryzyka arytmii. Atypowa AN jest *najczęściej pomijanym* wariantem — pacjent z normalną wagą, ale wszystkimi objawami psychicznymi i medycznymi, często nie dostaje leczenia. Wszystkie trzy warianty wymagają tego samego zaangażowania interdyscyplinarnego.

△ Pytanie różnicujące AN-BP od BN: BMI w momencie oceny. AN-BP — BMI poniżej 18,5 (dorośli); BN — BMI w normie lub wyższe. To nie wyklucza, że objawy psychiczne mogą być podobne — ale leczenie i ryzyko medyczne różnią się. W razie wątpliwości — konsultacja specjalistyczna w ośrodku zaburzeń odżywiania.